

Traitement des pathologies allergiques:

ANTIHISTAMINIQUES (Anti H1):

- Nez: $\rightarrow$ rhinorrhée fluide, $\rightarrow$ éternuements, $\rightarrow$ prurit. Peu effets sur obstrucⁿ nasale.
- Œil: $\rightarrow$ larmoiement et prurit
- Peau: $\rightarrow$ prurit, $\rightarrow$ urticaire.
- Bronches: Peu ou pas d'effets sur l'asthme.

• 1^{ère} générat^o:

Efficacité +++ pris per os, mais sédatifs, action anticholinergique.

Utilisat^o: hydrosolubles $\rightarrow$ inj. i.v. possible en urgence, prurit (surtout nocturne).

• 2^{ème} générat^o: peu hydrosoluble $\rightarrow$ voie orale très utile

Efficacité +++ et sélectifs $\Rightarrow$ pratiquement pas sédatifs (passent pas BHE), pas d'effet anti-cholin.

Différences de métabolisme utilisables en cas d'insuffisance hépatique/rénale. Certains ok p^{dt} grossesse.

• Antihistaminiques topiques: collyres oculaires et sprays pour nez

Bonne efficacité antiallergique, surtout pour conjonctivite. Action rapide, durée 12h. Taux sanguins faibles

$\rightarrow$ utilisables p^{dt} grossesse et allaitement. Effets 2nd locaux bénins. (Prix $\geq$ 2x anti-H1).

CROMONES (TOPIQUES) = sels disodiques: (ac. cromoglycique p. ex).

Moins efficaces que corticoïdes topiques dans rhinite, mais très utiles dans conjonctivite.

Inhibition de la dégranulation mastocytaire. Emploi dans la conjonctivite.

STEROÏDES TOPIQUES (INHALES) (STI):

$\rightarrow$ inflammat^o $\Rightarrow$ efficacité +++ . Indispensables dans le ttt de l'asthme (si $>$ 1 crise/sem.) et de la rhinite, y compris obstructive. Très peu d'effets systémiques aux doses prescrites $\Rightarrow$ ttt de choix pour grossesse et allaitement. Souvent assoc. aux bronchodilat. de longue durée d'act^o.

ANTI-LEUCOTRIÈNES (per os):

Effet anti-infl. $\leftarrow$ corticoïdes topiques, effet bronchodilatateur léger. Assoc. possible avec STI pour

$\rightarrow$ la dose. Utilisat^o dans l'asthme d'effort ou avec intolérance à l'aspirine et polypose nasale (secr. bcp LT) et la rhinite obstructive.

BRONCHODILATEURS (β_2 -agonistes):

Efficacité en 2-4 min pour β_2 de courte durée + formotérol. Durée d'action soit courte (4-6h) ou longue (12h). Utilisés en inhalation. Effets 2nd: tremor, tachycardie supraventr., hypok⁺, sécheresse buccale, céphalées. Assoc. oblig. avec ttt anti-infl. dès que néc.

$\rightarrow$ salbutamol, formotérol, terbutaline, formotérol

NOUVEAUX MÉDICAMENTS:

$\rightarrow$ au niv. C₆₃ $\Rightarrow$ peuvent pas se lier à α_2 des Fc ϵ RI

• Anti-IgE: Fixe fract^o libre IgE, $\rightarrow$ Fc ϵ RI de surface baso. et CD $(\uparrow 3\times$ ds asthme sévère p.r. asthme mod.). coûteux +++

• Anti-IL-5 et anti-IL-4/IL-13: études encourageantes ds asthme très sévère.